_PDF导出样章_临时

PDF 导出验证样章（口腔·临时）

> 本文件为 2026-10-14 质检后 Better Export PDF 小样本导出的临时样章，覆盖标题层级（H1 – H4，用于 PDF 书签）、表格、三类 callout、图片、分页。导出后删除。

一、表格渲染验证

模块	章节	周次	重点
M04	口腔黏膜常见疾病	第13周	RAU 三型、白斑癌变率
M06	口腔临床麻醉与牙拔除术	第14周	局麻药选择、禁忌数值、干槽症
M07	口腔颌面部感染与损伤	第14-15周	冠周炎、间隙感染、Le Fort
M08	唾液腺疾病与颌面部肿瘤	第15周	急性化脓性腮腺炎、多形性腺瘤

二、Callout 渲染验证

学习顺序建议

按 M01→M02→M03→M04→M06→M07→M08 顺序学习；其中 M06 麻醉拔牙 与 M07 间隙感染 为期末与执业医师高频区。

易错陷阱

口腔颌面部间隙感染中，口底多间隙蜂窝织炎（卢德维咽峡炎） 应早期广泛切开，不可等待脓肿完全形成；这是最常见的误判点。

记忆

「牙片看根尖、全景看全局、CBCT 看三维、MRI 看软组织」；活检才是肿瘤定性的金标准。

2.1 第一性原理示例

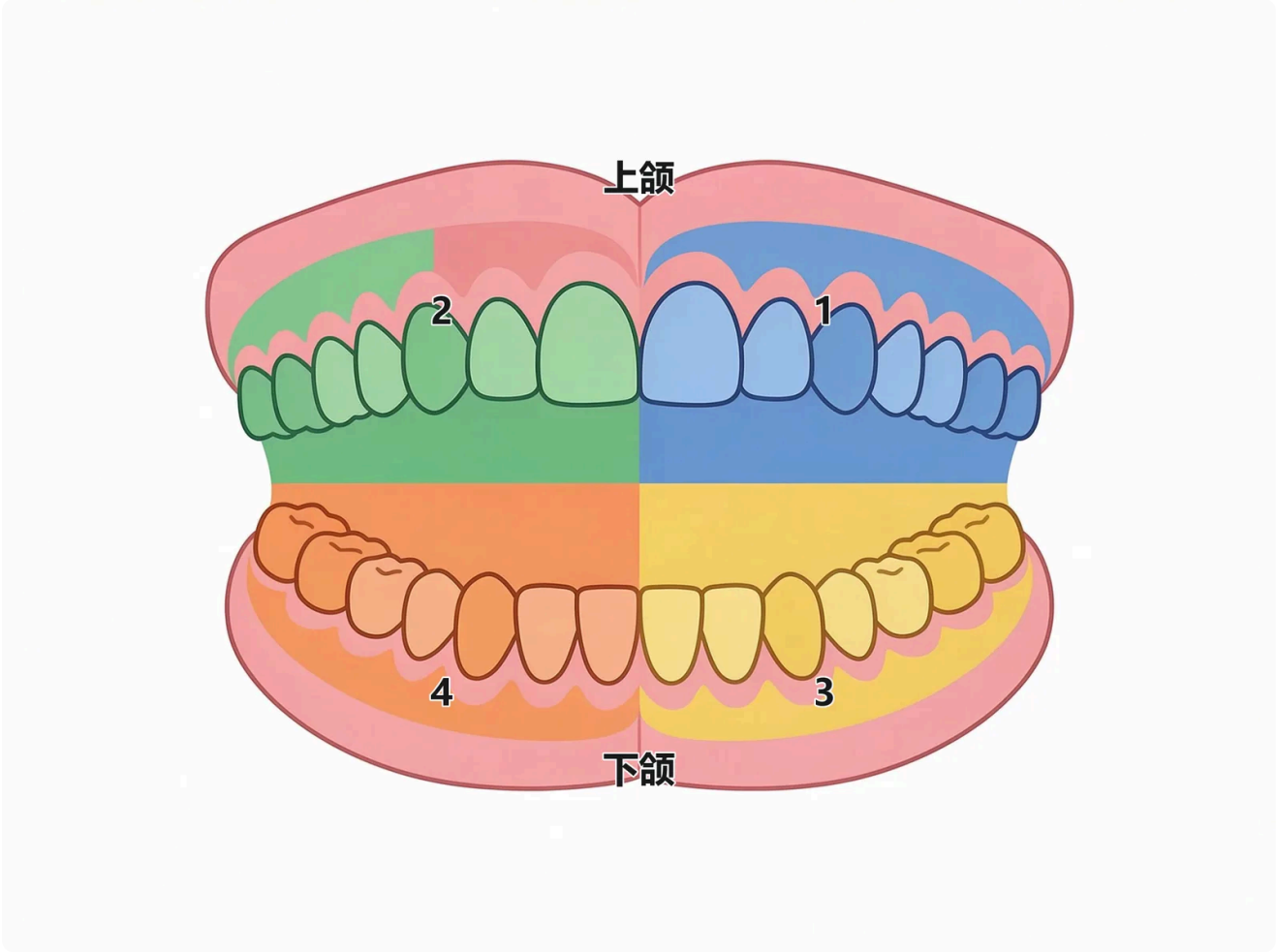
🧬 第一性原理：间隙感染的扩散方向由筋膜间隙的连通关系决定，理解了间隙的解剖边界，就推出了脓肿切开部位与呼吸困难的进展顺序。

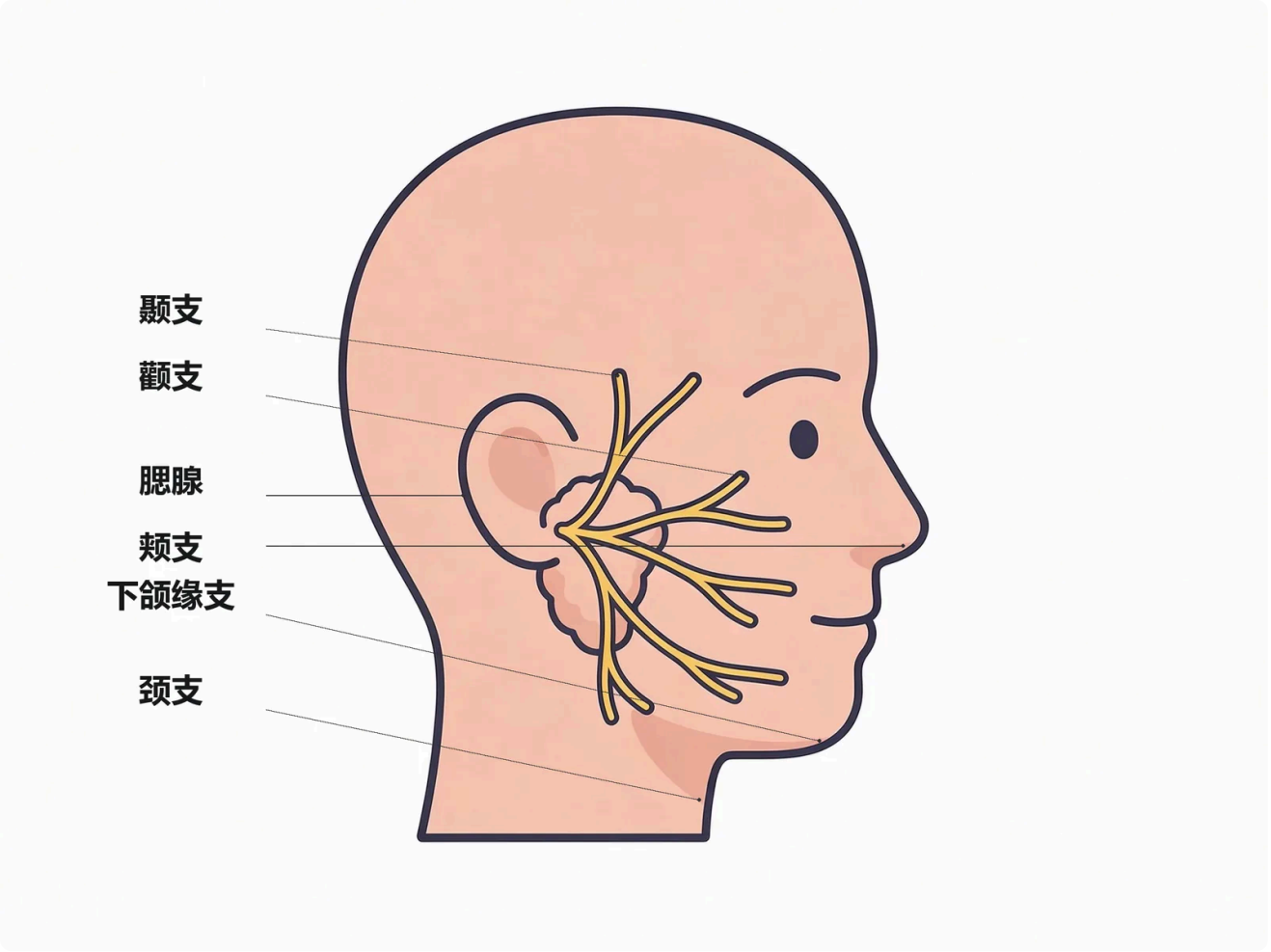
2.2 展开区标题验证

🔬 展开：咀嚼肌功能与骨折移位

展开区使用 `#### 🔬` 标题（非 details），在 PDF 中应作为一个普通四级标题出现并进入书签。

三、图片渲染验证（相对路径 images_webp）





四、分页与书签验证

4.1 占位正文

下面用一段长文本制造跨页，用于检查分页、页眉页脚与页码是否连续、标题是否孤行。

循证医学强调，复习手册的价值在于把分散的知识点组织为可检索、可迁移的临床结构。颌面部感染的诊断首先依据红肿热痛与功能障碍的定位，再结合张口受限、吞咽困难、呼吸困难等判断累及间隙；影像学以 CT 三维重建为首选，治疗遵循抗感染与脓肿切开并重，全身支持治疗不可忽视。面神经五支自腮腺缘呈扇形穿出，颞支损伤致额纹消失、颧支损伤致眼睑不能闭合、颊支损伤致鼻唇沟变平与鼓腮漏气、下颌缘支损伤致下唇歪斜、颈支影响较小。

4.2 牙位与麻醉

FDI 二位数牙位记录法中，恒牙列分为四个象限，十字的竖线区分上下、横线区分左右；拔牙局麻首选利多卡因，心律失常患者亦首选，麻醉方式分为浸润与阻滞，上牙槽后神经阻滞、下牙槽神经阻滞、腭前神经阻滞、鼻腭神经阻滞各有其解剖标志与进针点。

4.2.1 四级标题书签

本行为四级标题，用于确认 PDF 书签大纲包含 H1 – H4 四层。

- 拔牙禁忌需控制血压，术前一般控制在 140/90 mmHg 以下，至少不超过 160/100 mmHg。
- 糖尿病患者空腹血糖宜控制在 8.88 mmol/L 以下。
- 妊娠 4–6 个月为相对安全期。

4.3 结语文本

样章结束。若本 PDF 中：① 表格有边框与表头底色；② 三类 callout 呈蓝/红/绿彩色块且内部加粗正常；③ 两张 FDI/面神经图片正常显示；④ 页码连续、书签含四级标题、无明显孤行断表——则 Obsidian 兼容与 Better Export PDF 导出验证通过。